

STEP 2 환자 교육

공감	쉽게 멍드는 증상이 갑자기 발생하여 많이 걱정이 되셨을 텐데요,
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진을 종합해 보았을 때 가장 의심되는 질환은 특발혈소판감소자반병입니다. 이 질환은 혈소판의 기능 이상으로 출혈이 생겨 멍이 쉽게 들 수 있는 질환입니다.
감별 진단	하지만 이 외에도 혈소판 이상을 일으킬 수 있는 다른 질환도 완전히 배제할 수 없습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 기본 혈액검사인 전혈구검사와 혈액응고시간검사, 말초혈액도말검사를 시행하고자 합니다. 괜찮으신가요?
치료	만약 검사 후에도 이 질환으로 진단이 되면 혈소판의 수치에 따라 스테로이드나 면역 글로불린 등의 치료가 필요할 수 있습니다. 하지만 대부분의 경우에는 감기 증상 후 일시적으로 발생하는 증상이므로 크게 걱정하실 필요는 없습니다.
예후	지금부터 잘 치료를 받으시면 호전되실 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.
교육	[출혈 위험 예방 교육] ① 외부 활동 자제, 외상 유발 상황 피하기 : 양치질 부드럽게, 코 살짝 풀기, 전기면도기 사용하기, 격한 운동 피하기 ② 출혈 심할 때 바로 내원 : 멍이 계속 커짐, 코피 안 멎음, 토혈/객혈, 혈변/흑색변, 어지럼, 호흡곤란 ③ 수술이나 발치 필요 시 의사와 반드시 상의 ④ 약물 복용 시 주의
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① 혈액검사 : CBC, LFT
- ② ITP, TTP : 응고 시간 측정(Bleeding time, aPTT, PT), 응고인자검사
- ③ Cushing : 야간 텍사메타손 부하검사
- ④ Liver disease : 간기능검사, 간초음파검사, 복부 CT
- ⑤ Leukemia : 말초혈액도말검사, 골수검사

❖ 치료 계획

- ① ITP : glucocorticoid → IVIG(면역 글로불린) → splenectomy
- ② TTP : plasmapheresis(혈장분리교환술), 면역억제제, FFP(fresh frozen plasma)
- ③ 혈우병 : 응고인자 보충(factor 8, 9 concentrate), cryoprecipitate(혈우병 A)

❖ 환자 안내/생활 습관 교육(출혈 위험 예방 교육)

- ① ITP일 확률이 높은 경우 일시적으로 그럴 수 있다고 하면서 환자를 안심
- ② 출혈이 쉽게 일어나고 잘 멎지 않으므로 상처를 입지 않도록 하고, 특히 노인 환자의 경우 두개강 내 출혈의 위험성이 더 높으므로 주의해야 함을 강조
- ③ 심한 두통, 시야장애, 혈변, 흑변 등 위급한 증상이 보이면 바로 병원 오기
- ④ 아스피린 및 진통소염제 등의 약제는 혈소판 기능을 저하시키는 부작용이 있어 혈소판감소증이 있는 환자가 복용하는 경우 출혈 경향을 더욱 증가시킬 수 있으므로 가급적 사용하지 않도록 한다.
- ⑤ 발치 등의 시술이나 수술 전에는 의사와 반드시 상의
- ⑥ 전기면도기 이용, 부드러운 칫솔 사용, 과도한 운동이나 야외 활동 금지 등의 생활 습관에 대한 교육



keyword

출혈 유무를 확인하고, 있다면 출혈의 정도(탈수 증상 등)를 확인하기
멍의 크기, 색, 통증, 눌렀을 때 하얗게 소실되는지 등 특징에 대해 자세히 문진하기
신체 진찰 : 문진 내용 직접 확인하기, 간/ 비장 신체 진찰 시행하기
특발혈소판감소자반병은 대부분 경과 관찰을 요하기에 환자 안심시키기
외상 유발 상황 피하고, 출혈이 심할 경우 즉시 병원에 내원하고, 수술이나 발치 시
의사와 반드시 상의하도록 교육하기

시험 관령 코멘트



피로는 비특이적 증상으로 증상의 지속 기간에 따라 1개월 미만 지속되는 피로를 급성 피로, 6개월 이상 지속되는 피로를 만성 피로로 정의합니다. 피로를 유발하는 질환에는 기질적 원인과 그 외 신경, 정신적 원인, 약물 사용, 원인불명 등 다양한 원인이 존재합니다. 따라서 기질적 원인이 의심될 시 계통별로 질문을 해야 하며, 원인불명의 피로의 경우 대표적으로 만성 피로증후군을 의심해 진단 기준 증상 8가지 중 4개 이상을 만족 시 진단을 내릴 수 있습니다.

문진 시 **정신과 질환에 대해 감별해야 한다는 것을 명심**하고, 이전에 **건강 검진을 받은 적이 있는 지를 꼭 물어보아** 합니다.

신체 진찰 시 **갑상샘저하증을 감별하기 위해 목 진찰을 하는 것을 잊지** 맙시다. 그 외 환자가 호소하는 증상에 따라 신체 검진이 달라질 수 있습니다.

환자 교육이 중요한 파트로 올바른 생활 교육을 하는 것이 중요합니다. 음주를 줄이고, 야식을 끊어야 하며, 규칙적인 운동으로 체중 조절과 충분한 수면을 취해야 합니다. 생활 습관을 교정했음에도 코골이 증상이 좋아지지 않는다면 CPAP 등의 치치가 필요할 수도 있습니다. 또한 카페인 섭취가 수면을 질을 떨어뜨릴 수 있으므로 카페인 섭취 감량을 권유해야 합니다. 큰 병이 아닐 경우 안심시켜 주는 것도 필요하겠습니다.

원인 감별과 환자 교육으로 시간이 빠듯한 모듈이니 다양한 감별 진단에 대해 골고루 질문하면서 시간 조절을 하시는 것이 좋습니다.

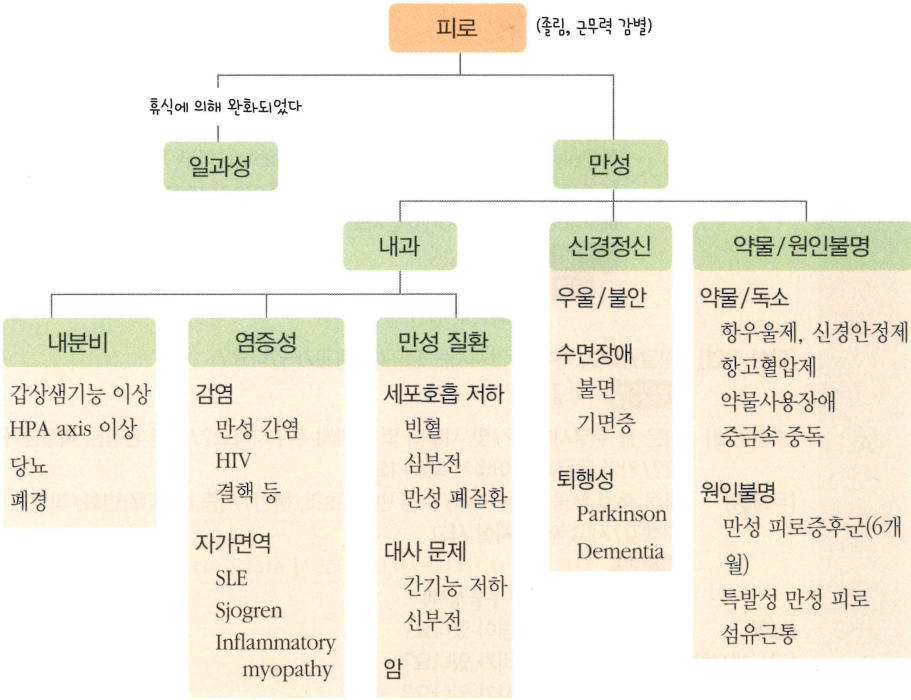
질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	원인	질병	진단 키워드	검사/치료
정신과		일과성 피로	[병력] 너무 무리해서 피곤한 것, 사회력 중요, 피로 외 다른 증상 ×, 휴식에 의한 완화	[치료] 휴식, 안심시키기, 규칙적 식사, 충분한 수면, 적절한 운동
		주요 우울증 / 수면장애* (해당 항목 참조)	[병력] 우울, 식욕 저하, 의욕 저하, 체중 감소, 불면, 만성 피로 [검진] 신체 진찰 정상	[검사] Beck의 우울척도검사 [치료] SSRI, 증상이 심한 경우 입원 치료

정신과	만성 피로증후군★ (chronic fatigue syndrome) (4~8개월)	[병력] (인기다경근두운잠) 전신 근육통, 인후통, 운동 후 권태감, 6개월 이상 지속, 다른 문제 없음 [검진] 신체 진찰 정상	[검사] 다른 검사 진행 후 배제 진단 [치료] 규칙적 식습관, 유산소 운동, 수면 위생, 항우울제, 인지 행동 치료
	섬유근통★ (fibromyalgia)	[병력] 피로, 근골격계 통증, 의식 혼탁, 수면장애, 감각이상, 집중력 저하 [검진] CBC, ESR, CRP 등 주로 정상	[검사] 임상 증상으로 진단 [치료] 환자 교육, 보존적 치료
내분비	에디슨병 (addison's disease)	[병력] 메스꺼움, 구토, 체중 감소, 피부 착색 [검진] 입 점막 주위 착색	[검사] 혈중 코티솔 농도, ACTH 농도, ACTH 투여 후 코티솔 농도 검사 [치료] Hydrocortisone, Prednisone
	갑상샘저하증★ (hypothyroidism)	[병력] 추위불내성, 변비, 체중 증가, 피부 푸석 [검진] 갑상샘 종대되어 있을 수도	[검사] 갑상샘기능검사 [치료] Levothyroxine
종양	종양	[병력] 체중 감소, 장기 이상 증상	[검사] Tumor marker, PET/CT [치료] 수술, 항암 치료, 방사선 치료
호흡기	폐결핵★ (tuberculosis)	[병력] 발열, 객혈, 피로, 체중 감소, 야간 발한, 이전에 결핵 걸렸던 적 있음 [검진] 특이 소견 없음	[검사] 객담 항산염색, 투베르쿨린 검사 [치료] 항결핵제(Isoniazid, Rifampin, Pyrazinamide, Ethambutol)
순환기	빈혈 (anemia)	[병력] 호흡곤란, 피로, 어지럼, 위수술력 [검진] 결막 창백	[검사] CBC, PBS, 혈중 Fe/TIBC/Ferritin [치료] 철분 보충, 코발아민/비타민 B ₁₂

순환기	울혈 심부전 (chronic heart failure)	[병력] 호흡곤란, 오목 부종, 체중 증가 [검진] 경정맥 확장, 심잡음	[검사] 심초음파, 심전도 [치료] Nitrate, 이뇨제
소화기	만성 간염 (chronic hepatitis)	[병력] 황달, 이상한 음식 먹은 것 [검진] 간비대, 황달, 복수	[검사] 간기능검사, HBsAg, anti-HBc, anti-HCV [치료] 리바비린, 엔테카비어 등

증례별 알고리즘



기본 진찰 사항

STEP 1 병력 청취

O	언제부터 피로감이 느껴졌나요? (6개월이 지났는지?)
L	어떤 상황에서 피곤하셨나요?
D	하루 종일 피곤한가요? or 간헐적으로 피곤한가요? 아침에 더 피곤한가요?
Co	점점 더 피로감이 심해지나요?
Ex	이전에도 이런 적이 있었나요?
C	[양상] 어떤 증상을 피로하다고 하시는건가요? → 팔다리 근력(힘) 감소, 호흡곤란(숨 참), 집중력 저하, 수면 부족 암기법 ▶ 힘을 숨기고 집중해서 잠을 잔다. 하루 중 언제 가장 심하신가 [정도] 일상 생활에 지장이 있나요?
A	[전신] 발열/오한/체중 변화/피로 [만성 피로증후군] 운동 후 심한 권태감(Exhausted)/근육통(Muscle pain)/다발성 관절 통(Polyarthralgia)/새로운 두통(Headache)/경부, 액외부 림프절 압통(Adenopathy or tender LN)/인후통(Sore throat)/기억력, 집중력장애(Impaired memory)/잠자도 피곤하신가요(Sleep problems)? 암기법 ▶ EMPHASIS 설명 위 8가지 증상 중 4가지 이상이 동시에 6개월 이상 지속 & 타 질환으로 원인 설명 불가 [만성 간염] 황달/복수/복부에 만져지는 덩이(간비대)가 있나요? 암기법 ▶ 황금 복덩이 [수면장애] 잠은 잘 주무시나요?/몇 시부터 몇 시까지 주무시나요?/수면 환경은 적절한가요?/키와 몸무게가 어떻게 되시나요? [우울증] 하루 종일 우울/의욕 저하/수면 변화/초조, 불안/체중 or 식욕 변화/피로/자책감/사고 저하/자살 사고 암기법 ▶ 하루 살이가 자다가 정신 차리고 살 찌려고 피자 사먹자 (MDD=주요우울장애) [빈혈] 호흡곤란/어지럼이 있나요? [갑상샘저하증] 추위불내성/변비가 있나요? [갑상샘항진증] 더위불내성/설사가 있나요? [결핵] 야간 발한/호흡곤란/기침/가래/인후통이 있나요? [CHF] 오목 부종/체중 증가가 있나요? 암기법 ▶ 간수 우변이가 갑질을 결심

F	[스트레스] 스트레스를 많이 받으셨나요? [완화] 휴식한 뒤에는 호전이 되나요?/운동한 뒤에 호전되나요? [악화] 피로를 악화시키는 요인이 있나요?
E	이전에 건강 검진을 받으신 적 있나요? (빈혈, 간질환)
외	[수술] 이전에 위절제술을 받으신 적 있나요?
과	진단 받은 질병이 있으신가요? (HTN, Tb, 갑상샘, 간, 우울증, 수면장애)
약	복용 중인 약물이 있나요? (항고혈압제, 항우울제, 약물 남용)
사	술, 담배 하시나요?/커피는 드시나요?/직업이 어떻게 되시나요?/운동은 하시나요?
	[식습관] 영양 상태는 어떠세요?
가	가족분들 중에 암/결핵을 앓으셨던 분이 계신가요?
여	월경과다가 있나요?
P/E	☞ 환자가 호소하는 증상에 따라 해야 할 신체 검진이 달라질 수 있습니다. 비교적 흔하게 발생하는 갑상샘저하증을 감별하기 위해 목 진찰을 꼭 하고, 그 외 흉부나 복부, 사지 진찰 중에서 시간에 맞게 선택적으로 시행하도록 합니다. 이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기!). [앉아서] 1. 눈 : 결막(빈혈), 공막(황달) 2. 입 : 구강 점막(색깔 변화) 3. 목★: 갑상샘, 림프절 비대 4. 피부 : 색 변화, 선조 5. 흉부 : 심음, 호흡음 청진 [누워서] 6. 복부 : 시-청-타-촉(간비대) 7. 사지 : 하지 부종/근력 측정 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 점은 없으신가요?